

CRISES HIPERTENSIVAS



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

PA MUITO ELEVADA SEM LESÃO DE ÓRGÃO-ALVO

- **Uso Oral (Anti-hipertensivos):**

Hidralazina 25 mg ---- 2 comprimidos

Tomar 2 comprimidos por via oral agora.

Ou

Hidralazina 50 mg ---- 1 comprimido

Tomar 1 comprimido por via oral agora.

Ou

Clonidina 0,1 mg --- 1 comprimido

Tomar 1 comprimido por via oral agora.

Ou

Captopril 50 mg ----1 comprimido

Tomar 1 comprimido via oral agora.



ROTINA CLÍNICA

PA MUITO ELEVADA SEM LESÃO DE ÓRGÃO-ALVO

- **Cuidados gerais em cenário de atendimento:**

1. Avaliar repetir medicações ou associar novas classes de acordo com o controle pressórico.
2. Sempre descartar lesões de órgão-alvo.
3. Encaminhar a UBS para seguimento ambulatorial.
4. Avaliar início de anti-hipertensivos orais para uso domiciliar.
5. Orientar retorno em caso de sinais de alarme como dor torácica, dispneia, pré-síncope, cefaleia intensa e outros.



EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

- **Uso parenteral:**

Nitroglicerina (Tridil)

Diluição padrão: 1 ampola de 5 ml em 245 ml de SG 5% ou SF 0,9%.

A dose inicial: 5 a 10 µg/minuto com ajuste a cada 5 minutos.

Nitroprussiato de sódio (Nipride)

Diluição: 1 ampola de 2 ml em 248 ml de SG 5% (fotossensível, use equipo fotoprotetor).

Iniciar a 0,3 µg/kg/minuto.

Na prática: iniciar em dose baixa, geralmente, a 5 ml/h em BIC, e titular de acordo com os alvos pressóricos a serem alcançados.



EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

- **Uso sublingual:**

Dinitrato de isossorbida (Isordil)

Administrar 1 comprimido via sublingual. Se necessário, pode ser utilizado a cada 5 minutos (por até 3 vezes) em caso de dor torácica.

- **Cuidados gerais em cenário de emergência:**

1. Transferir o paciente para a sala vermelha;
2. Oxigenioterapia sob cateter nasal ou máscara a critério médico para manter Sat. O₂ > 94%;
3. Monitorização com oximetria de pulso, monitorização eletrocardiográfica e multiparamétrica;
4. Solicitar exames de acordo com a suspeita de lesão de órgão-alvo.



EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

- **Cuidados gerais em cenário de emergência:**

5. Reduzir a pressão arterial em 20 a 25% na primeira hora.

6. Meta pressórica de 160/110 mmHg ou 160/100 mmHg em 2 a 6 horas de tratamento.

7. Suporte clínico e hemodinâmico.

